ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 7 · 27 СЕНТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Санитарные нормы: инвентарь, уборки, классы чистоты

Цветовая маркировка уборочного инвентаря, виды уборочного материала, правила маркировки, алгоритм генеральной уборки, виды уборок, классы чистоты А–Г

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Маркировка уборочного инвентаря
2. Виды уборочного материала
3. Алгоритм генеральной уборки
4. Кварцевание (УФ-облучение)
5. Классы чистоты помещений
6. Медицинские отходы
7. Виды уборок подробно · подробнее
8. Безвёдерная уборка и инвентарь · подробнее
9. Кварцевание подробно · подробнее
10. Классы чистоты по слайдам · подробнее
11. Медицинские отходы · подробнее
12. Инфекционная безопасность УЗИ-кабинета · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Маркировка уборочного инвентаря

СУТЬ
Каждый цвет — своя зона. Так грязь из туалета никогда не попадёт в операционную.

Весь инвентарь должен иметь чёткую маркировку с указанием помещения, чтобы исключить **перекрёстное заражение**.



Красный	Жёлтый	Зелёный	Синий	Белый
туалеты, душевые, грязное бельё	процедурные, перевязочные	операционные, реанимации	коридоры, палаты, кабинеты	лестницы, столовые

⚠ красный инвентарь хранят отдельно и нигде больше не используют

Классическая цветовая кодировка уборочного инвентаря

Цвет	Зона
🔴 Красный	Санитарные зоны: туалеты, душевые, места хранения грязного белья и отходов
🟡 Жёлтый	Помещения со средней степенью загрязнения: процедурные, перевязочные, манипуляционные
🟢 Зелёный	Чистые/режимные помещения: операционные, родовые, реанимации, палаты интенсивной терапии
🔵 Синий	Общие зоны с наименьшим загрязнением: коридоры, холлы, палаты, кабинеты персонала
⚪ Белый	Другие помещения: лестницы, столовые

ВАЖНО
Инвентарь для туалетов маркируется **сигнальным красным**, хранится отдельно и **больше нигде не используется**.

2 Виды уборочного материала

Различается по назначению и конструкции; маркировка нужна, чтобы предотвратить перекрёстное загрязнение.

1. **Для пола и стен**: швабры, мопы, ёмкости для воды, вёдра, тазы. Инвентарь для пола и для стен — **раздельный**.
2. **Для поверхностей и оборудования**: ветошь (протирочная и промывочная), салфетки, пульверизаторы, щётки. Для оргтехники — отдельная «компьютерная» ветошь.
3. **Для сухой уборки**: пылесосы, веники, совки, метёлки.
4. **Вспомогательное оборудование**: уборочные тележки, мешки для мусора.

Правила маркировки

- Наносят водостойкой краской или перманентным маркером; надпись должна быть читаемой.
- Маркировка бывает текстовой и цветовой.
- Принципы: по **назначению помещения** (основной; туалеты — только красный, отдельное хранение), в медицинских помещениях учитывают **класс чистоты**, по **виду поверхностей**, по **структурному подразделению**.



Безвёдерная уборка

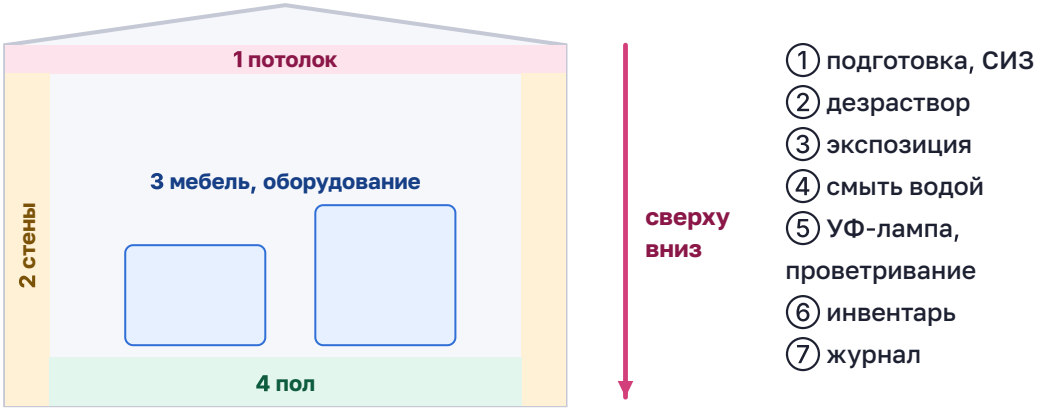
- мопы заранее пропитаны раствором
- 1 моп = 1 помещение (не более 20 м²)
- палаты — синий моп, санузлы — красный
- использованный моп — в сетку/мешок на стирку и дезинфекцию
- губки и пористые материалы запрещены (кроме мытья посуды)

Безвёдерная уборка мопами

3 Алгоритм генеральной уборки

суть
Генуборка: подготовка → мытьё сверху вниз дезраствором → экспозиция → смывание → бактерицидная лампа и журнал.

Периодичность: не реже **1 раза в месяц** в обычных помещениях; в помещениях с асептическим режимом (процедурные, операционные) — чаще (по санитарным нормам — 1 раз в неделю).



Порядок обработки при генеральной уборке

1. **Подготовка**: надеть спецодежду (халат, шапочка, маска, перчатки); освободить помещение от предметов, отодвинуть мебель от стен.
2. **Обработка поверхностей**: подготовить дезраствор, мыть последовательно: **потолок → стены → оборудование → пол**.
3. **Экспозиция**: выдержать время обеззараживания согласно инструкции к средству.
4. **Смывание** (при необходимости): надеть чистую спецодежду и смыть остатки дезраствора чистой водой.
5. **Завершение**: включить бактерицидную лампу (по инструкции), проветрить, промыть и обеззаразить инвентарь, сделать отметку в **журнале генеральных уборок**.

Виды уборки: предварительная, текущая, заключительная, генеральная (генеральную проводят другими дезсредствами).

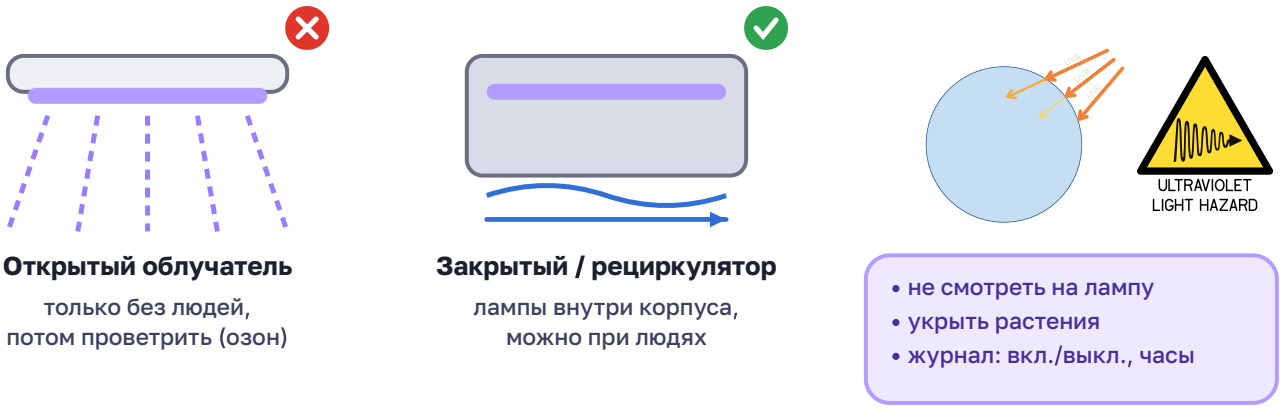


Генеральная — по графику: асептические 1 раз в неделю, палаты и кабинеты 1 раз в месяц
внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям

Виды уборок в течение дня

4 Кварцевание (УФ-облучение)

СУТЬ
Ультрафиолет убивает микробов на поверхностях и в воздухе, но опасен для глаз: открытые лампы — только без людей.



Открытый облучатель
только без людей, потом проветрить (озон)

Закрытый / рециркулятор
лампы внутри корпуса, можно при людях

- не смотреть на лампу
- укрыть растения
- журнал: вкл./выкл., часы

Открытые и закрытые облучатели

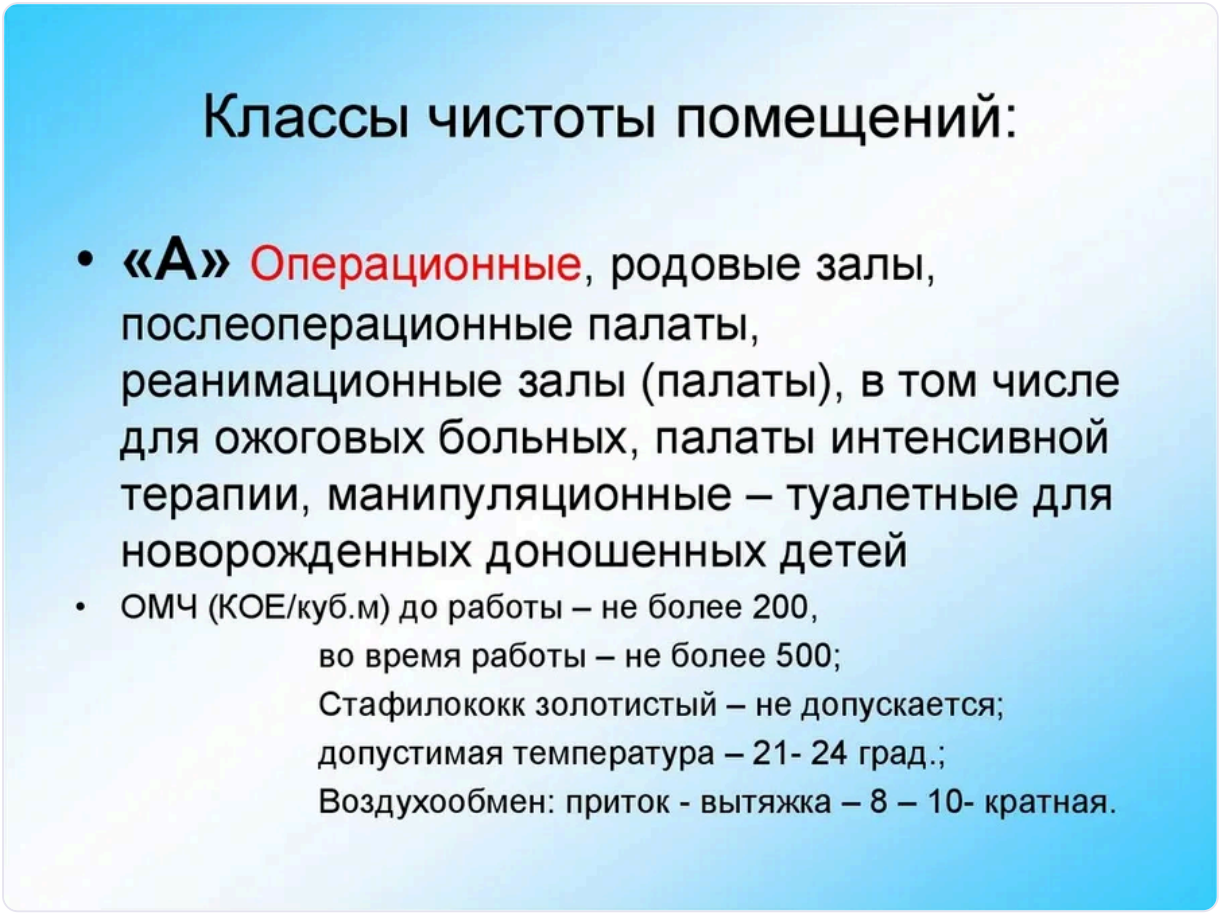
- Нельзя находиться в помещении и смотреть на открытую лампу — **ожог роговицы**, симптомы через несколько часов.
- У детей до 14 лет глаза в 3 раза чувствительнее к УФ.
- Прикрыть растения, после облучения проветрить.
- УФ действует только на то, куда попадают лучи, — поэтому вместе с уборкой.
- Работа ламп учитывается в журнале: дата, время включения и выключения.

5 Классы чистоты помещений

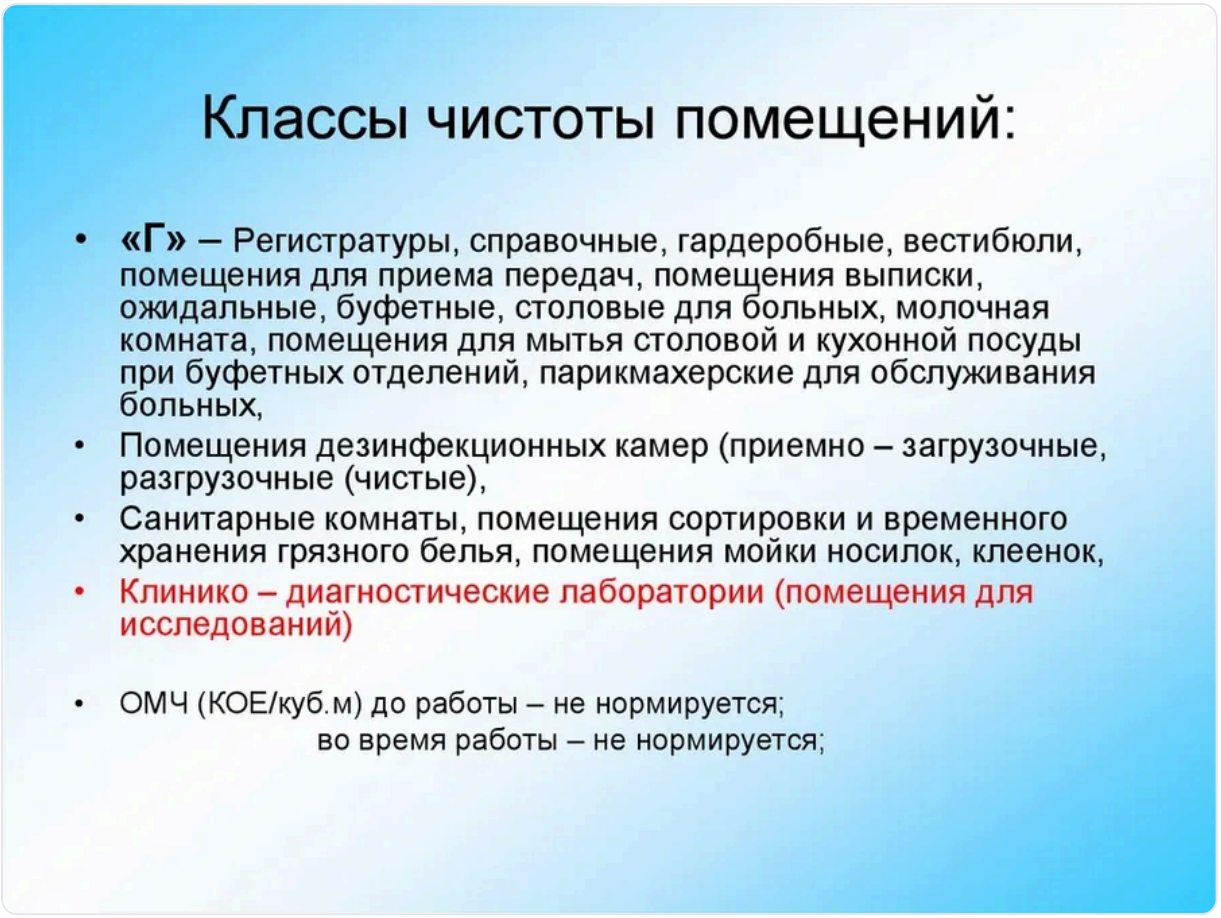
СУТЬ
Чем чище класс, тем меньше микробов допускается в кубометре воздуха.



Допустимая обсеменённость воздуха по классам (КОЕ/м³)



Слайд: класс А



Слайд: класс Г

Класс	Помещения	Норма (КОЕ в 1 м³ воздуха)
А — особо чистые	операционные залы, асептические боксы	до 200
Б — чистые	процедурные, перевязочные, палаты реанимации	до 500
В — условно чистые	палаты хирургических отделений, коридоры у операционных, смотровые	до 750
Г — грязные	коридоры административных зданий, лестницы, туалеты, грязные бельевые	не устанавливается

ⓘ КОЕ — колониеобразующие единицы: сколько колоний микробов вырастает из пробы воздуха.

6 Медицинские отходы

суть
Отходы делят на 5 классов: А — как бытовые, Б — опасные (жёлтый), В — чрезвычайно опасные (красный), Г — токсичные, Д — радиоактивные.

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4



безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	**ёмкость «Класс Г»**	**спец. контейнер**

Классы медицинских отходов

- Пакеты и контейнеры заполняют **на 3/4**, завязывают стяжкой, маркируют: организация, отделение, дата, ФИО.
- Отходы Б и В обязательно обеззараживают.
- Пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже 72 ч.
- Нельзя пересыпать, утрамбовывать руками, снимать иглы руками, надевать колпачки на использованные иглы.

Отходы класса А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов (ухой мусор, упаковка, мебель, инвентарь, пищевые отходы). Сбор отходов класса А проводится в многоразовые емкости с маркировкой «Отходы класса А» и одноразовые пакеты, *любого цвета,* **кроме желтого и красного,** заполняются на ¾ объема, завязываются и помещаются в уличный контейнер с маркировкой «Отходы класса А». **Емкости многоразовые освобождаются и моются ежедневно. Дезинфицируются 1 раз в неделю**	Отходы класса Б – инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Органические операционные отходы (органы и ткани и др.). Пищевые отходы из инфекционных отделений – туберкулез, гепатит и т.д. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Живые вакцины, непригодные к использованию. **Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции.** Сбор отходов класса Б в одноразовую мягкую или твердую упаковку **желтого цвета.** После заполнения пакета на ¾, пакет завязывается с помощью бирок- стяжек. Твердые емкости закрываются крышками. **При упаковке** отходов класса Б пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. **Смена одноразовых пакетов** не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно. Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса Б.	Отходы класса В – материалы контактировавшие с больными особо – опасными инфекционными болезнями, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно – диагностических подразделений, (загрязненные мокротой пациентов), осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. **Отходы В подлежат обязательной дезинфекции.** Сбор отходов класса В в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую, не прокалываемую упаковку (контейнеры с крышкой, обеспечивающей их герметизацию) **красного цвета** или имеющий **красную маркировку**. После заполнения **пакета на ¾**, пакет завязывается с помощью бирок – стяжек. Твердые (не прокалываемые) емкости закрываются крышками. **При упаковке** отходов класса В пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного, за сбор отходов лица. **Смена одноразовых пакетов** не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно. Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса В.	Отходы класса Г – лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. **Ртуть содержащие** предметы, приборы и оборудование. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и др. **Сбор, хранение отходов** класс Г проводится в специально выделенном помещении в маркированную упаковку «Отходы класса Г» **Вывоз отходов** класса Г осуществляется специализированными организациями.	Отходы класса Д - радиоактивные отходы рентгенологические пленки и оборудование. **Вывоз отходов** класса Д осуществляется специализированными организациями.

Таблица классов отходов (доп. материалы)

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

7 Виды уборок подробно

Вид уборки	Когда и как
Предварительная	утром перед работой: убрать осевшую за ночь пыль, обработать поверхности дезраствором, включить бактерицидную лампу
Текущая	в течение дня, не реже 2 раз в сутки; в процедурных и перевязочных — 2 раза, в операционной — после каждой операции, в буфете — после каждого приёма пищи; между пациентами — обработка кушетки и поверхностей
Заключительная	в конце рабочего дня: полы, поверхности на высоте роста, стены; удаление отходов; кварцевание
Генеральная	по графику: помещения с асептическим режимом (операционные, процедурные, перевязочные, родзалы) — **1 раз в неделю**, палаты и кабинеты — **1 раз в месяц**; внепланово — при плохих смывах и по эпидпоказаниям



Уборки в течение дня

- Предварительная — утром: пыль за ночь, полы, стены, подоконники с антисептиком; в конце — бактерицидная лампа.
- Текущая: в операционной — после каждого пациента (вирулицидный режим), в столовой — после каждого приёма пищи, в родзале — 3 раза в день, в процедурной и перевязочной — 2 раза в день, в административных помещениях — 1 раз в день.
- Заключительная — в конце дня: полы, поверхности на высоте роста, удаление отходов, кварцевание.
- После генеральной уборки персонал сдаёт рабочую одежду в прачечную.

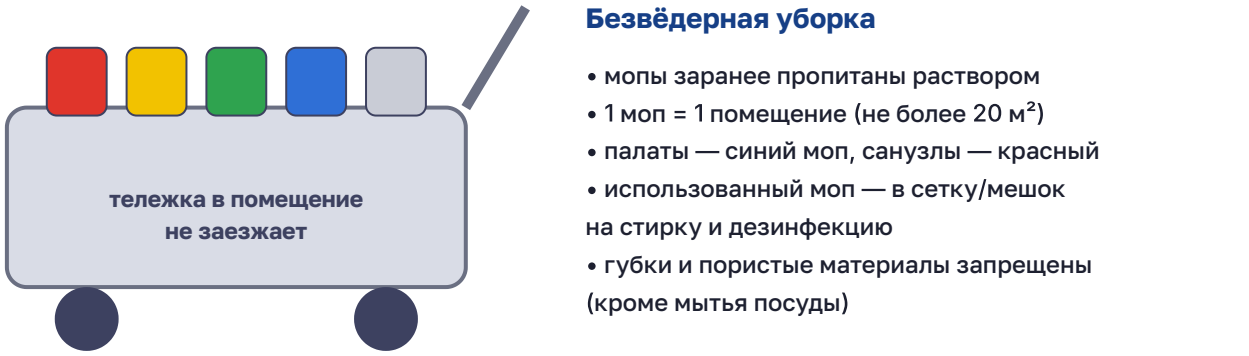
Генеральная уборка по шагам

1. Надеть спецодежду для генуборки: халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, фартук; взять инвентарь с маркировкой «Для генеральной уборки».
2. Освободить помещение от предметов, отодвинуть мебель от стен, отключить приборы.
3. Нанести дезраствор (протирание или орошение 150–300 мл на 1 м²) сверху вниз: **потолок → стены, окна, двери → мебель, оборудование → пол**.

4. Выдержать экспозицию по инструкции к средству (помещение закрыто).
5. Сменить спецодежду, смыть дезраствор чистой водой стерильной/чистой ветошью.
6. Включить бактерицидный облучатель (по расчёту, обычно 1 Вт на 1 м³, около 2 ч), затем проветрить.
7. Инвентарь обеззаразить погружением в дезраствор, прополоскать, высушить.
8. Записать в журнал генеральных уборок: дата, средство и концентрация, ФИО и подпись.

ⓘ Генуборку в инфекционных стационарах проводят 1 раз в 7–10 дней; окна изнутри моют 1 раз в месяц, снаружи — 1 раз в полгода. Пол моют от дальнего конца комнаты, тщательно углы и плинтусы, затем центр.

8 Безвёдерная уборка и инвентарь



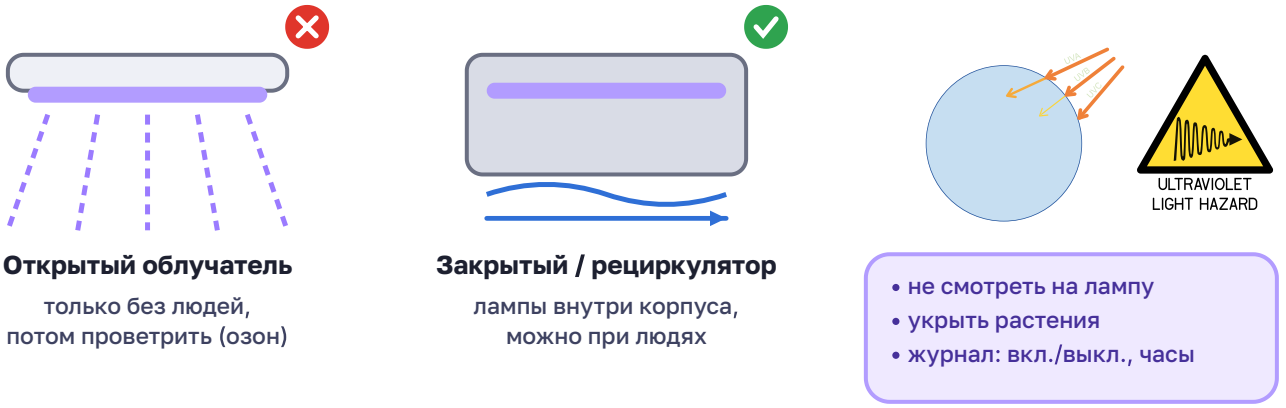
Безвёдерная уборка



Цветовая маркировка

- Губки и пористые материалы в МО запрещены (кроме мытья посуды на пищеблоке).
- Вёдра с оцинковкой нельзя использовать с кислотными растворами.
- Инвентарь после уборки замачивают в дезрастворе, затем стирают, полощут, сушат и хранят в отведённом месте.
- Для каждого помещения — свой инвентарь; для генуборки — отдельный, с маркировкой «Для генеральной уборки».

9 Кварцевание подробно



Облучатели

- Открытые облучатели — облучают всё помещение, только в отсутствие людей.
- Закрытые облучатели и рециркуляторы — лампы в корпусе, можно при людях, непрерывно.
- Кварцевые (ртутно-кварцевые) лампы дают озон — обязательно проветривание; безозоновые бактерицидные — 253,7 нм.
- После генуборки — облучение около 2 ч из расчёта 1 Вт на 1 м³.

ВАЖНО
Ожог роговицы при включённой лампе: сначала лёгкая боль в глазах, через ~6 часов — резь, слёзы, светобоязнь, отёк век. Обязательно к врачу.

10 Классы чистоты по слайдам



Классы чистоты

Классы чистоты помещений:

- **«А»** Операционные, родовые залы, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, манипуляционные – туалетные для новорожденных доношенных детей
- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не более 200,
  во время работы – не более 500;
  Стафилококк золотистый – не допускается;
  допустимая температура – 21- 24 град.;
  Воздухообмен: приток - вытяжка – 8 – 10- кратная.

Класс А: операционные, родовые, реанимации

Классы чистоты помещений:

- **«Б»** – Процедурные и асептические, перевязочные, процедурные бронхоскопии.

- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не более 500,
  во время работы – не нормируется;
  Стафилококк золотистый не допускается;
- допустимая температура – 20- 26 град.;
  Воздухообмен: приток – 8 – кратный,
  вытяжка – 6 - кратная.

Класс Б: процедурные, перевязочные

Классы чистоты помещений:

- **«Б»** – ЦСО: чистая и стерильная зоны (контроля, комплектования и упаковки чистых инструментов, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, стерилизации и экспедиции)

- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не более 500,
  во время работы – не более 750;
  Стафилококк золотистый не допускается;
- допустимая температура – 20- 27 град.;
  Воздухообмен: приток – 10 – кратный, вытяжка – 8 - кратная.

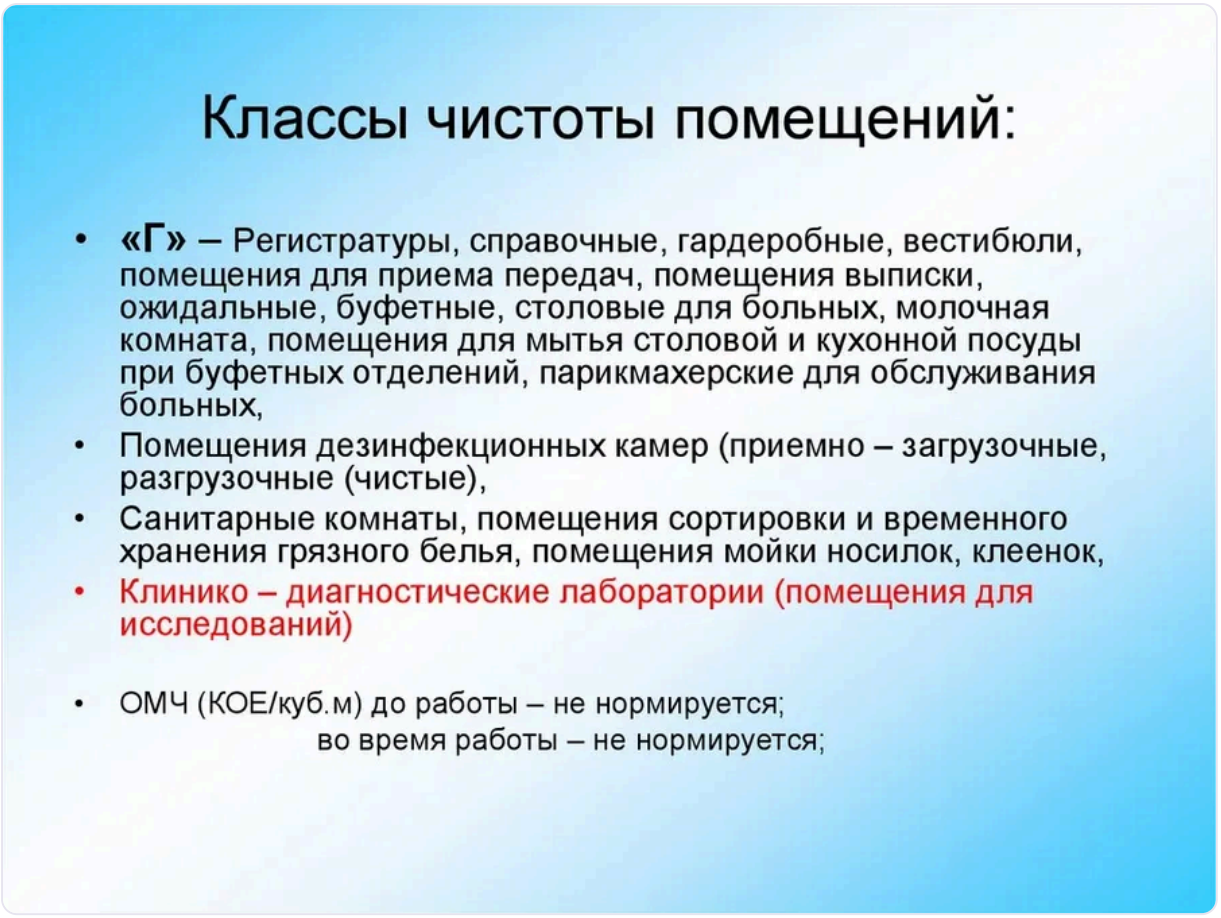
Класс Б: ЦСО

Классы чистоты помещений:

- **«В»** – Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии).

- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не нормируется,
  во время работы – не нормируется;
- допустимая температура – 20- 27 град.;
  Воздухообмен: приток – вытяжка – из расчета 60 м3/ час на 1 человека.

Класс В: кабинеты врачей, функциональная диагностика



Класс Г: регистратуры, санкомнаты, бельевые

ⓘ Слайды по СанПиН 2.1.3.2630-10 (приложение 3): ОМЧ — общее микробное число, КОЕ в 1 м³ воздуха до и во время работы; золотистый стафилококк в классах А и Б не допускается.

11 Медицинские отходы

Медицинские отходы — все виды отходов, образующиеся в медицинских организациях при оказании медпомощи, проведении медицинских исследований, а также в аптеках, лабораториях, на фармпроизводствах. Делятся на **5 классов опасности** (СанПиН 2.1.3684-21).

Классы медицинских отходов (СанПиН 2.1.3684-21) · заполнять на 3/4

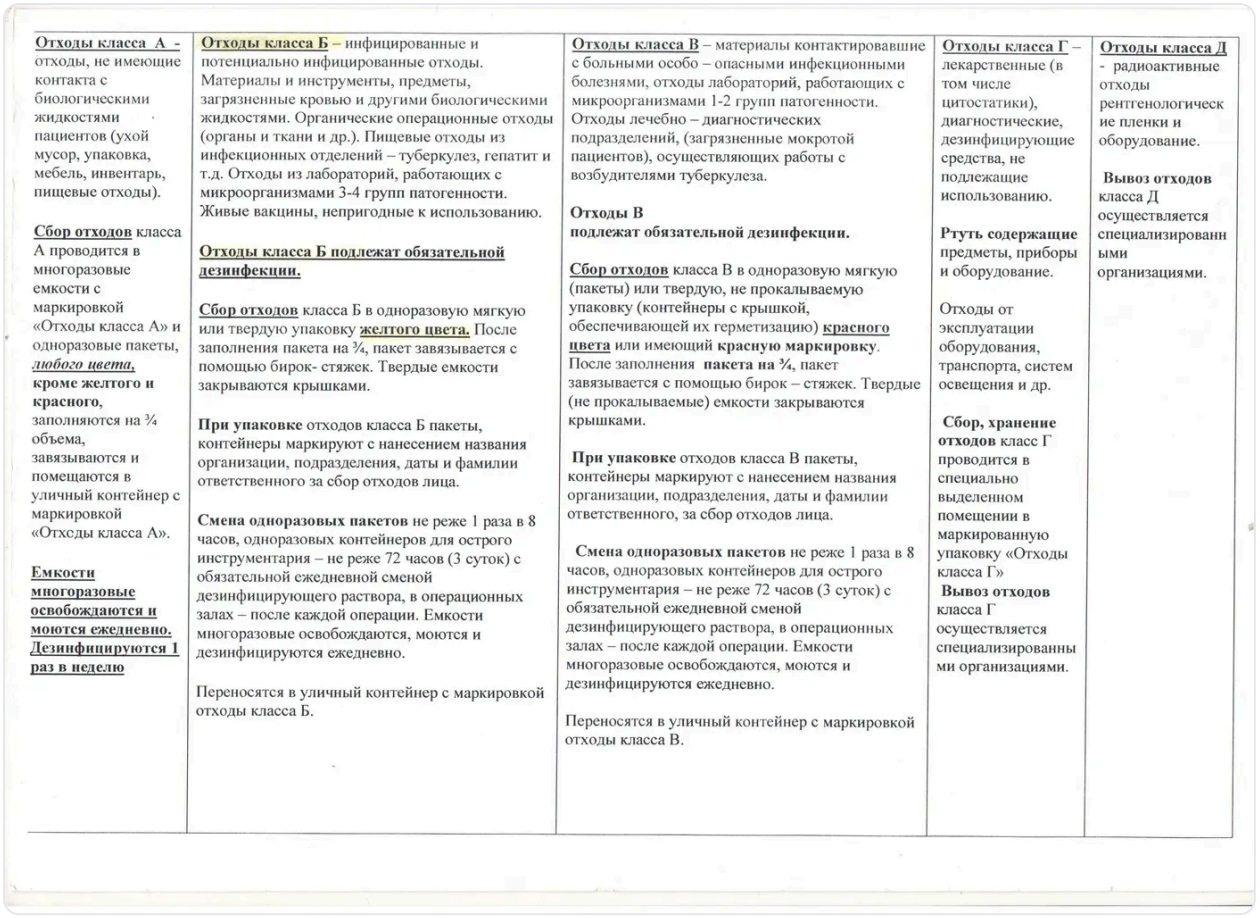


А	Б	В	Г	Д
безопасные	**опасные**	**чрезвычайно опасные**	**токсичные**	**радиоактивные**
бумага, упаковка, пищевые (неинфекц.)	шприцы, системы, перевязка, перчатки	ООИ, туберкулёз, лаборатории 1–2 гр.	лекарства, цитостатики, ртуть, дезсредства	источники излучения, рентгеноплёнки
любой цвет, кроме жёлтого и красного	жёлтый	красный	ёмкость «Класс Г»	спец. контейнер

Классы отходов

Класс	Что это	Упаковка
А — эпидемиологически безопасные	не контактировали с биожидкостями и инфекционными больными: бумага, упаковка, пищевые отходы (кроме инфекционных), мебель, инвентарь, смёт с территории	любой цвет, **кроме жёлтого и красного**
Б — эпидемиологически опасные	загрязнённые кровью и биожидкостями (шприцы, системы, перевязка, перчатки), органические операционные отходы, пищевые отходы инфекционных отделений, отходы лабораторий с микробами 3–4 групп патогенности, непригодные живые вакцины	**жёлтая** (или с жёлтой маркировкой)
В — чрезвычайно эпидемиологически опасные	контакт с больными особо опасными инфекциями; лаборатории, работающие с микробами 1–2 групп патогенности; отходы фтизиатрических (туберкулёз) подразделений, загрязнённые мокротой	**красная** (или с красной маркировкой)
Г — токсикологически опасные	лекарства (в т. ч. цитостатики), диагностические и дезсредства, не подлежащие использованию; ртутьсодержащие предметы и приборы; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, освещения	маркированные ёмкости «Отходы. Класс Г»
Д — радиоактивные	радиоактивные отходы, рентгенологические плёнки и оборудование	по правилам радиационной безопасности

- Пакеты и контейнеры заполняют **не более чем на 3/4**, пакет завязывают бирками-стяжками, твёрдые ёмкости закрывают крышками.
- На упаковке отходов Б и В пишут: название организации, подразделение, дату и ФИО ответственного за сбор.
- Одноразовые пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже чем через 72 ч (3 сут), в операционных — после каждой операции.
- Многоразовые ёмкости ежедневно освобождают, моют и дезинфицируют.
- Нельзя: пересыпать отходы Б и В из одной ёмкости в другую, утрамбовывать руками, снимать иглу вручную, надевать колпачок на использованную иглу, собирать острое в мягкую упаковку, работать без СИЗ.



Отходы класса А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов (ухой мусор, упаковка, мебель, инвентарь, пищевые отходы). **Сбор отходов** класса А проводится в многоразовые емкости с маркировкой «Отходы класса А» и одноразовые пакеты, ***любого цвета,*** **кроме желтого и красного**, заполняются на ¾ объема, завязываются и помещаются в уличный контейнер с маркировкой «Отходы класса А». **Емкости многоразовые освобождаются и моются ежедневно. Дезинфицируются 1 раз в неделю**	**Отходы класса Б** – инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Органические операционные отходы (органы и ткани и др.). Пищевые отходы из инфекционных отделений – туберкулез, гепатит и т.д. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Живые вакцины, непригодные к использованию. **Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции.** **Сбор отходов** класса Б в одноразовую мягкую или твердую упаковку **желтого цвета.** После заполнения пакета на ¾, пакет завязывается с помощью бирок- стяжек. Твердые емкости закрываются крышками. **При упаковке** отходов класса Б пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. **Смена одноразовых пакетов** не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно. Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса Б.	**Отходы класса В** – материалы контактировавшие с больными особо – опасными инфекционными болезнями, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно – диагностических подразделений, (загрязненные мокротой пациентов), осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза. **Отходы В подлежат обязательной дезинфекции.** **Сбор отходов** класса В в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую, не прокалываемую упаковку (контейнеры с крышкой, обеспечивающей их герметизацию) **красного цвета** или имеющий **красную маркировку**. После заполнения **пакета на ¾**, пакет завязывается с помощью бирок – стяжек. Твердые (не прокалываемые) емкости закрываются крышками. **При упаковке** отходов класса В пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного, за сбор отходов лица. **Смена одноразовых пакетов** не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно. Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса В.	**Отходы класса Г** – лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. **Ртуть содержащие** предметы, приборы и оборудование. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и др. **Сбор, хранение отходов** класс Г проводится в специально выделенном помещении в маркированную упаковку «Отходы класса Г» **Вывоз отходов** класса Г осуществляется специализированными организациями.	**Отходы класса Д** - радиоактивные отходы рентгенологические пленки и оборудование. **Вывоз отходов** класса Д осуществляется специализированными организациями.

Таблица классов отходов

12 Инфекционная безопасность УЗИ-кабинета

- текущая уборка 2 раза в день; консоль аппарата и держатели датчиков — не реже 1 раза в смену; кушетку — после каждого пациента;
- для полостных исследований — стерильный гель (или с бактериостатическими свойствами); флаконы заполнять только после опорожнения, очистки и дезинфекции;
- датчики протирать дезраствором в начале смены и после каждого исследования; остатки средства удалять безворсовыми салфетками;
- защитные чехлы снимать аккуратно, без разбрызгивания; гигиена рук.

📌 Что запомнить

- Красный — туалеты и санзоны (только там, хранится отдельно); жёлтый — процедурные, перевязочные; зелёный — операционные, реанимации; синий — коридоры, палаты, кабинеты; белый — лестницы, столовые.
- Инвентарь для пола и для стен — раздельный; для оргтехники — своя ветошь.
- Маркировка — водостойкой краской или перманентным маркером.
- Генуборка — не реже 1 раза в месяц (асептические помещения — чаще); порядок: потолок → стены → оборудование → пол.
- Генуборка: подготовка, обработка, экспозиция, смывание, бактерицидная лампа + проветривание + журнал.
- Виды уборки: предварительная, текущая, заключительная, генеральная.
- Классы чистоты: А до 200, Б до 500, В до 750 КОЕ/м³, Г — не нормируется.
- Открытые УФ-лампы — только без людей; потом проветрить.
- Отходы: А — любой цвет кроме жёлтого и красного, Б — жёлтый, В — красный, Г — токсичные, Д — радиоактивные; заполнять на 3/4.

🃏 Вопросы для самопроверки

Цвет инвентаря для туалетов
Красный (сигнальный), хранится отдельно, нигде больше не используется

Цвет инвентаря для операционных и реанимаций
Зелёный

Цвет инвентаря для процедурных и перевязочных
Жёлтый

Цвет инвентаря для коридоров и палат
Синий

Порядок мытья при генуборке
Потолок → стены → оборудование → пол

Периодичность генуборки в обычных помещениях
Не реже 1 раза в месяц

Чем завершают генуборку?
Бактерицидная лампа, проветривание, обработка инвентаря, запись в журнале

Класс чистоты А
Особо чистые: операционные, асептические боксы — до 200 КОЕ/м³

Класс чистоты Б
Чистые: процедурные, перевязочные, реанимация — до 500 КОЕ/м³

Класс чистоты В
Условно чистые: палаты хирургии, коридоры у операционных, смотровые — до 750 КОЕ/м³

Класс чистоты Г
Грязные: туалеты, лестницы, грязные бельевые — норма не устанавливается

Цвет пакета для отходов класса Б
Жёлтый

Цвет пакета для отходов класса В
Красный

На сколько заполняют пакет с отходами?
На 3/4

Можно ли находиться в помещении при открытой УФ-лампе?
Нет — ожог роговицы

✅ Тест с ответами

1. Каким цветом маркируют инвентарь для туалетов?
Ответ: Красным — Сигнальный красный; хранится отдельно.

2. Правильный порядок мытья при генеральной уборке:
Ответ: Потолок → стены → оборудование → пол — Сверху вниз: потолок, стены, оборудование, пол.

3. Операционная относится к классу чистоты…
Ответ: А — Класс А — особо чистые, до 200 КОЕ/м³.

4. Допустимая обсеменённость воздуха в процедурной (класс Б):
Ответ: до 500 КОЕ/м³ — Класс Б — до 500.

5. Как часто проводят генуборку в обычных помещениях?
Ответ: Не реже 1 раза в месяц — Не реже 1 раза в месяц.

6. Чем маркируют инвентарь?
Ответ: Водостойкой краской или перманентным маркером — Маркировка должна быть стойкой и читаемой.

7. Отходы класса Б собирают в пакеты…
Ответ: жёлтые — Б — жёлтые, В — красные.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.